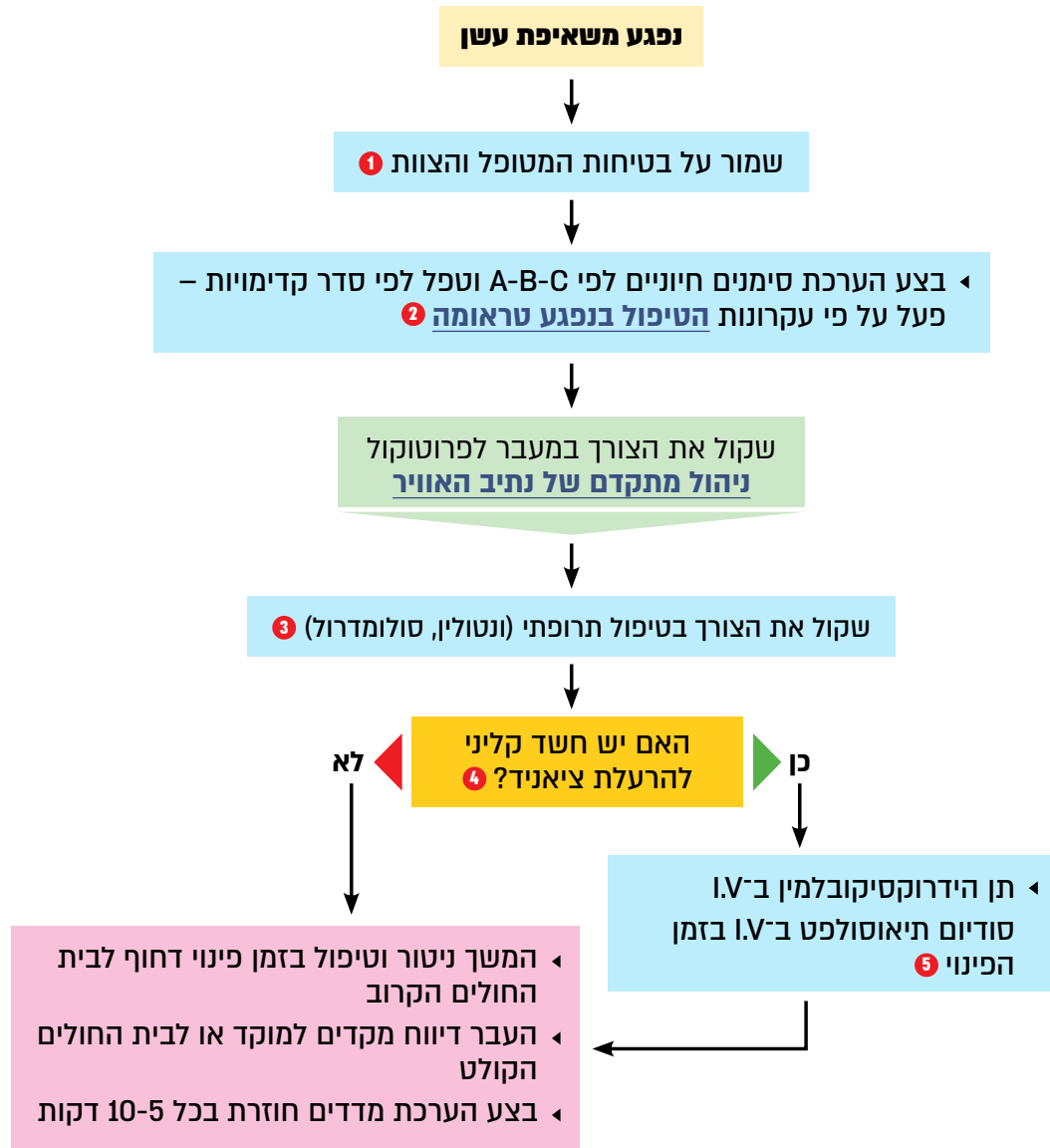




- 1** + בטיחות – שקול את הצורך בשימוש בנשמיות.
 + בחשד להרעלת ציאניד – הטיפול יינתן במהלך הפינוי.
 + בהחייאה – יש להתחיל את הטיפול באנטידוט מוקדם ככל האפשר.

- 2 דגשים לטיפול הראשוני**
 + תן חמצן לכל נפגע הסובל משאיפת עשן.
 + שקול ביצוע אינטובציה בשלב מוקדם – בכל נפגע משאיפת עשן עם הפרעה או "איום" על נתיב האוויר, או כשיש חשד סביר להתפתחות הפרעה כזו בהמשך.
 + בנפגעים הסובלים גם מכוויות יש לטפל בהתאם להוראות פרוטוקול **טיפול בנפגע כוויות**.

- 3 טיפול תרופתי**
 + אינהלציה של ונטולין ובנוסף סולומדרול ב-I.V. – לכל נפגע הסובל מברונכוספזם, בהתאם להוראות פרוטוקול **התקף אסתמה במבוגר**.

- 4 במקרים אלה יש חשד קליני להרעלת ציאניד**
 + דום לב.
 + ירידה במצב ההכרה של המטופל שלא כתוצאה מחבלת ראש.
 + המטופל מציג סימנים לירידה בפרפוזיה ו/או לחץ הדם הסיסטולי שלו נמוך מ-90 mmHg (שלא נוצר עקב דימום מסיבי).

- 5 אנטידוטים להרעלת ציאניד**
הידרוקסיקובלמין ב-I.V.
 + למבוגרים – 5 gr בהזלפה תוך 15 דקות.
 + לילדים – 70 mg/kg (עד למקסימום של 5 gr) בהזלפה תוך 15 דקות.
סודיום תיאוסולפט ב-I.V.
 + למבוגרים – 10-12.5 gr בהזלפה תוך 10 דקות.
 + לילדים – 400 mg/kg (עד למקסימום של 12.5 gr) בהזלפה תוך 10 דקות.

אין לתת את שני האנטידוטים בו זמנית באמצעות אותה גישה ורידית.

תוכן עניינים > כללי : פרק 5

כללי

- + פגיעה משולבת כתוצאה משאיפת עשן –
 - נזק תרמי לדרכי הנשימה.
 - פגיעה ריאתית כתוצאה מחשיפה לכימיקלים שונים.
 - הרעלה מערכתית (סיסטמית) משנית לשאיפת רעלנים (טוקסינים, כגון CO או ציאניד).

הרעלת ציאניד

- + **המנגנון** – עיכוב תוך־תאי של המטבוליזם האירובי.
- + **חשיפה** – שאיפת גזים רעילים המשתחררים במהלך בעירה חלקית של חומרים סינתטיים.
- + **קליניקה** – **חשיפה לציאניד במינון גבוה תביא למוות בתוך דקות מספר.**
- + **ממצאים מחשידיים** – דום לב, שוק מסיבה לא ברורה, שינויים במצב ההכרה, פרכוסים, הפרעות קצב, ברדיפניאה. לעיתים יופיע ריח שקדים אופייני.
- + **מעבדה** – חמצת מטבולית לקטית, ירידה ב־PCO₂, עלייה בערכי סטורציה בווריד, רמות גבוהות של ציאניד בדם.
- + **עקרונות הטיפול** –
 - מתן חמצן בריכוז גבוה, סיוע נשימתי, תמיכה המודינמית, מתן אנטידוטים ייחודיים.
 - **בעת ביצוע החייאה בנפגע משאיפת עשן יש להתחיל בהזלפת האנטידוט מוקדם ככל האפשר.**
 - יש לשקול מתן אנטידוט למטופלים שחולצו ממבנים בוערים המציגים סימנים קליניים לפגיעה משאיפת עשן, וכן מציגים את אחד מהבאים:
 - ירידה במצב ההכרה או חוסר הכרה שלא כתוצאה מחבלת ראש.
 - פרכוסים.
 - הפרעות קצב.
 - ירידה בפרפוזיה ו/או לחץ דם סיסטולי נמוך מ־90 mmHg (שלא נוצר עקב דימום מסיבי).

אנטידוטים בשימוש במד"א

+ הידרוקסיקובלמין

- מנגנון הפעולה – נקשר ישירות לציאניד ויוצר את מולקולת הציאנוקובלמין, שאינה רעלנית ומופרשת בשתן.
- תופעות לוואי – עליית לחץ דם, שינוי צבע של השתן ושל הריריות, תגובה אלרגית.

+ סודיום תיאוסולפט

- מנגנון הפעולה – מעודד הפיכת ציאניד לתיוציאנט אשר מופרש בשתן.
- תופעות לוואי – ירידת לחץ דם, נזק לרקמה התת־עורית במקרה של דלף מהווריד, תגובה אלרגית.

אין לתת את שני האנטידוטים בו־זמנית באמצעות אותה גישה ורידית.